

Hepatites virais - A, B, C e agudização

Leia o painel sorológico como uma história temporal. HAV é aguda/fecal-oral; HBV pode cronificar e tem vacina; HCV cronifica com frequência e tem cura com DAAs.

Painel HBV em uma linha

Dica - Painel HBV em uma linha

HBsAg+ = infecção. Anti-HBs+ isolado = vacina. Anti-HBc+ com anti-HBs+ = infecção pregressa. IgM anti-HBc+ sugere agudo.

Triagem R1: via de transmissão + sorologia típica + desfecho (cura × cronicidade).



Condutas que caem

- HAV: suporte; imunoglobulina/vacina em contatos conforme cenário
- HBV agudo: suporte; antivirais em falência grave / reativação / imunossupressão
- HCV: genótipo menos decisivo hoje — tratar com DAA após confirmação de viremia
- Coinfecção HBV/HDV e HIV: piora evolução — sempre rastrear fatores de risco

Marcadores — atalhos

Marcador | Significado

IgM anti-HAV | Hepatite A aguda

HBsAg | Infecção HBV (aguda ou crônica)

HBeAg | Alta replicação / infectividade

Anti-HCV + RNA-HCV | Infecção HCV ativa

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Antes de imunossupressão/quimioterapia em HBsAg+ ou anti-HBc+, considere profilaxia antiviral — reativação de HBV pode ser fulminante. Não confunda anti-HBs vacinal com infecção ativa.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Child-Pugh e MELD quantificam gravidade da cirrose e priorizam prognóstico/transplante.

Bilirrubina, albumina, INR/TP, ascite e encefalopatia — 1 a 3 pontos cada.

Child-Pugh

A B C (5-15 pts)

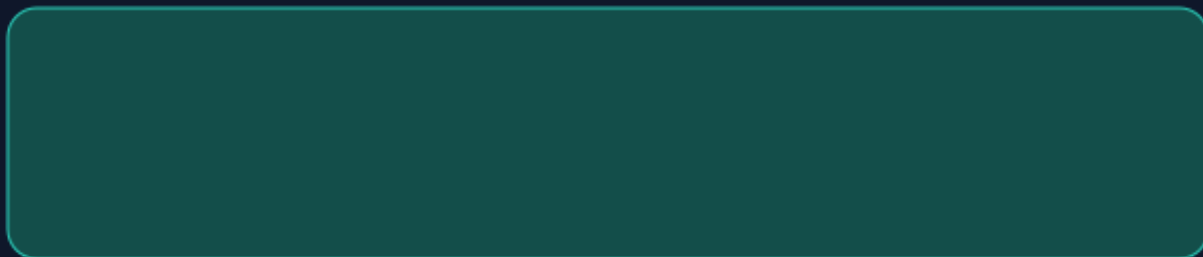
Bilirrubina	1-3
Albumina	1-3
INR / TP	1-3
Ascite	1-3
Encefalopatia	1-3

A 5-6 | B 7-9 | C 10-15

Usa bilirrubina, INR e creatinina ($\pm$ Na no MELD-Na). Prioriza fila de transplante.

MELD (ideia)

Escore contínuo



Child-Pugh — cortes clássicos

Variável | 1 pt | 2 pts | 3 pts

Bilirrubina (mg/dL) | < 2 | 2–3 | > 3

Albumina (g/dL) | > 3,5 | 2,8–3,5 | < 2,8

INR | < 1,7 | 1,7–2,2 | > 2,2

Ascite | ausente | leve/controlada | tensa/refratária

Encefalopatia | ausente | Grau I–II | Grau III–IV

Descompensações da cirrose

- Ascite: espironolactona $\pm$ furosemida; paracentese se tensa; albumina se grande volume
- PBE: PMN "e 250 no líquido; ATB + albumina em selecionados
- HDA varizes: vasoativo (terlipressina/octreotida) + ATB + endoscopia
- Encefalopatia: lactulose $\pm$ rifaximina; achar precipitante

Hepatites virais (prova rápida)

Dica - Hepatites virais (prova rápida)

HAV: IgM anti-HAV. HBV agudo: AgHBs + IgM anti-HBc. HBV crônico: AgHBs > 6 meses. HCV: anti-HCV + carga viral.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1